



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

**PEDOMAN PELAYANAN GIZI
STUNTING & WASTING**

**RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
TAHUN 2025**

Jl. Banjararum Selatan No. 3-7 Mondoroko - Singosari, Malang

Telp. 0341-458679, 458916, Fax. 441874

Email : sekretariat@malang.rs-primahusada.com

www.rs-primahusada.com

Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada
Nomor 629.1/I-PDM/DIR/VI/2025
Tentang
Pedoman Pelayanan Gizi Terkait Stunting dan Wasting

Disusun oleh :
Penanggungjawab Bab Program Nasional



(**Chandrawati Mustikasari, S. Tr. Gz**)

Disetujui oleh :
Authorized Person



(**Dr. dr. Aslichah, M.Kes AFP**)

Ditetapkan oleh :
Direktur Rumah Sakit Prima Husada



(**dr. Nur Mazidah**)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmatnya Pedoman Pelayanan Gizi Stunting & Wasting Rumah Sakit Prima Husada dapat diselesaikan dengan tepat waktu sesuai dengan kebutuhan RS. Prima Husada.

Pedoman Pelayanan Gizi Stunting & Wasting ini yang mulai dipergunakan pada tahun 2025. Kami mengucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun yang telah berjuang untuk menyelesaikan standar ini dengan baik. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada para kontributor yang telah memberikan masukan sangat berharga.

Semoga dengan dipergunakan Pedoman Pelayanan Gizi Stunting ini, mutu pelayanan dan keselamatan pasien rumah sakit Prima Husada dapat lebih baik.

Malang, 25 Juni 2025

Direktur Rumah Sakit Prima Husada



dr. Nur Mazidah

TIM PENYUSUN

PEDOMAN PROGRAM GIZI TERKAIT STUNTING DAN WASTING

PENGARAH

1. dr. Fiona Paramitha, Sp.A

PELAKSANA

1. dr. Fiona Paramitha, Sp.A
2. Chandrawati Mustikasari, S. Tr. Gz
3. Nafisah Ulfa Hasanah, S. Gz
4. Sistha Ghea Aprilianti, Amd.Kep
5. Tuti Dwi Jayati, AMd. Kep
6. Apt. Pipin Purwa Ningrum, S.Farm
7. Mike Maulina Sri Hartati S. Kep, Ners
8. Nuraini Radika Rifqi, S. Kep., Ns
9. Mayputri Nabilla

DAFTAR ISI

Sampul.....	1
Halaman Pengesahan	2
Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada	3
Kata Pengantar	6
Tim Penyusun.....	7
Daftar Isi.....	8
Daftar Tabel	9

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	9
1.2 Tujuan.....	10
1.2.1 Maksud	10
1.2.2 Tujuan Umum.....	10
1.2.3 Tujuan khusus	10
1.3 Sasaran	16

BAB II

TATA LAKSANA

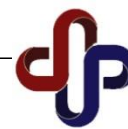
2.1 Pelayanan Gizi	11
2.2 Tumbuh Kembang Anak	12
2.3 Antropometri.....	13
2.4 Stunting	71
2.5 Rujukan	72

BAB III ORGANISASI TIM

3.1 Pimpinan dan Staf	73
3.2 Sarana dan Fasilitas Pengunjung	
3.3 Organisasi	
3.3.1 Kriteria.....	
3.3.2 Tugas dan Tanggung Jawab	
3.3.3 Tentang Staf Organisasi	

BAB IV

MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN.....	89
--	----



**PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
NOMOR 629.1/I-PDM/DIR/VI/2025**

TENTANG

PEDOMAN PROGRAM GIZI TERKAIT STUNTING & WASTING

DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif, perlu dilakukan identifikasi kejadian stunting sejak dini
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Direktur tentang Pedoman Kerja Stunting
- Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang–Undang Republik Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
4. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Promosi Kesehatan Rumah Sakit;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor hk.01.07/MENKES/1596/2024 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/d/47104/2024 tentang Instrumen Survei Akreditasi Rumah Sakit;
9. Keputusan Direktur Perseroan Terbatas Disa Prima Medika Nomor 263/DPM/I-KEP/DIR/I/2025 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Malang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
TENTANG PEDOMAN PROGRAM GIZI TERKAIT STUNTING DAN
WASTING**

Pasal 1

- (1) Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badan menurut umur kurang dari -2 SD, atau biasa disebut dengan balita pendek..
- (2) Wasting adalah kurangnya berat badan menurut panjang atau tinggi badan anak (BB/TB) atau biasa disebut dengan balita kurus.

Pasal 2

- (1) Rumah sakit menetapkan organisasi dalam bentuk tim yang mengurus tentang program penurunan prevalensi stunting dan wasting
- (2) Organisasi program penurunan tim stunting dan wasting dipimpin oleh staf medis atau dokter spesialis anak
- (3) Organisasi pelaksana program penurunan prevalensi stunting dan wasting terdiri dari tenaga kesehatan yang kompeten yang terdiri dari unsur:
 - a. Staf medis
 - b. Staf keperawatan
 - c. Staf instalasi farmasi
 - d. Staf instalasi gizi
 - e. Tim tumbuh kembang
 - f. Humas rumah sakit

Pasal 3

- (1) Rumah sakit menetapkan regulasi untuk terapi gizi terintegrasi
- (2) Asuhan gizi terintegrasi mencakup :
 - a) Deteksi dini
 - b) Rencana terapi
 - c) Pemberian terapi gizi
 - d) Monitoring dan evaluasi terapi gizi
- (3) Evaluasi dan monitoring terapi gizi dicatat di rekam medis pasien.

Pasal 4

- (1) Melakukan deteksi dini yang tepat terhadap tumbuh kembang anak
- (2) Deteksi dini dapat dilakukan dengan :
 - a) pengukuran antropometri yang tepat pada bayi dan balita
 - b) Penilaian perkembangan anak sesuai umur
- (3) Menilai status gizi berdasarkan Berat badan menurut Umur (BB/U), Panjang Badan menurut Umur (PB/U) atau Tinggi Badan menurut Umur (TB/U)
- (4) Dilakukan pencatat dan pelaporan ke instansi terkait dan dinas kesehatan

Pasal 5

- (1) Rumah sakit menetapkan regulasi tentang sistem rujukan untuk kasus gangguan gizi yang diperlukan penanganan lanjut.
- (2) Rumah sakit membuat proses sistem rujukan untuk gangguan gizi yang perlu penanganan lanjut.
- (3) Proses pelaporan sesuai dengan rujukan

Pasal 6

- (1) Peningkatan keahaman kesadaran seluruh staf, pasien, dan keluarga tentang masalah stunting dan wasting
- (2) Intervensi spesifik di rumah sakit
- (3) Rumah sakit sebagai pendamping klinis dan manajemen serta penguatan jejaring rujukan
- (4) Rumah sakit menerapkan rumah sakit sayang ibu dan bayi
- (5) Rumah sakit sebagai rujukan kasus stunting dan wasting
- (6) Melakukan pemantauan dan evaluasi

Pasal 7

- (1) Rumah sakit menetapkan strategi penurunan kasus stunting di lingkungan rumah sakit
 - a) Deteksi dini kejadian stunting pada anak dan balita
 - b) Memberikan Edukasi dan pendampingan gizi pada Ibu Hamil, Remaja Putri, bayi dan balita
 - c) Pemberian makanan tambahan Ibu hamil yang teridentifikasi KEK, remaja putri yang teridentifikasi anemia, dan bayi balita yang teridentifikasi stunting
- (2) Tujuan Strategi Penurunan Stunting
 - a) Menurunkan prevalensi Stunting

-
- b) Meningkatkan kualitas kehidupan sumber daya manusia
 - c) Meningkatkan pengetahuan terkait pola asuh dan asupan gizi
 - d) Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan

Pasal 8

Rumah sakit melakukan pendampingan intervensi dan pengelolaan gizi serta penguatan jejaring rujukan pada rumah sakit kelas dibawahnya dan FKTP

Pasal 9

Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 25 Juni 2025
Direktur Rumah Sakit Prima Husada



dr. Nur Mazidah

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA
NOMOR : 629.1/I-PDM/DIR/VI/2025
TENTANG
PEDOMAN PELAYANAN GIZI STUNTING &
WASTING

PEDOMAN PELAYANAN GIZI STUNTING & WASTING

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelayanan gizi di rumah sakit adalah pelayanan yang diberikan dan disesuaikan dengan keadaan pasien berdasarkan keadaan klinis, status gizi, dan status metabolisme tubuh. Keadaan gizi pasien sangat berpengaruh pada proses penyembuhan penyakit, sebaliknya proses perjalanan penyakit dapat berpengaruh terhadap keadaan gizi pasien. Sering terjadi kondisi pasien yang semakin buruk karena tidak tercukupinya kebutuhan zat gizi untuk perbaikan organ tubuh. Fungsi organ yang terganggu akan lebih memburuk dengan adanya penyakit dan kekurangan gizi. Selain itu masalah gizi lebih dan obesitas erat hubungannya dengan penyakit degeneratif, seperti diabetes melitus, penyakit jantung koroner, hipertensi, dan penyakit kanker, memerlukan terapi gizi untuk membantu penyembuhannya.

Masalah gizi klinis adalah masalah gizi klinis adalah masalah gizi yang ditinjau secara individual mengenai apa yang terjadi dalam tubuh seseorang, yang seharusnya ditanggulangi secara individu. Demikian pula masalah gizi pada berbagai keadaan sakit yang secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi proses penyembuhan, harus diperhatikan secara individual. Adanya kecenderungan peningkatan kasus penyakit yang terkait dengan gizi, *nutrition related disease* pada semua kelompok rentan dari ibu hamil, bayi, anak, remaja, dewasa, dan usia lanjut, semakin dirasakan perlunya penanganan khusus. Semua ini memerlukan pelayanan gizi yang bermutu untuk mempertahankan status gizi yang optimal, sehingga tidak terjadi kurang gizi dan untuk mempercepat penyembuhan.

Risiko kurang gizi akan muncul secara klinis pada orang sakit, terutama pada penderita anoreksia, kondisi mulut/gigi geligi buruk serta kesulitan menelan, penyakit saluran cerna disertai mual, muntah dan diare, infeksi berat, usila tidak sadar dalam waktu lama, kegagalan fungsi saluran pencernaan dan pasien yang mendapat kemoterapi. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sunita Almatsier di beberapa rumah sakit umum di Jakarta tahun 1991 menunjukkan 20%-60% pasien menderita kurang gizi pada saat dirawat di rumah sakit.

Oleh karena itu pelayanan gizi di rumah sakit yang merupakan hak setiap orang, memerlukan adanya sebuah pedoman agar diperoleh hasil pelayanan yang bermutu. Pedoman pelayanan gizi di dalam rumah sakit ini dikelola oleh pihak rumah sakit sendiri tidak melibatkan pihak ketiga.

Pelayanan gizi yang bermutu di rumah sakit akan membantu mempercepat proses penyembuhan pasien, yang berarti pula memperpendek lama hari rawat sehingga dapat menghemat biaya pengobatan. Keuntungan lain jika pasien cepat sembuh adalah mereka dapat segera kembali mencari nafkah untuk diri dan keluarganya. Hal ini sejalan dengan perkembangan iptek dibidang kesehatan, dimana telah berkembang terapi gizi medis yang merupakan kesatuan dari asuhan medis, asuhan keperawatan dan asuhan gizi.

Stunting merupakan sebuah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, hal ini menyebabkan adanya gangguan di masa yang akan datang yakni mengalami kesulitan dalam mencapai perkembangan fisik dan kognitif yang optimal. Anak stunting mempunyai Intelligence Quotient (IQ) lebih rendah dibandingkan rata – rata IQ anak normal (Kemenkes RI, 2018).

Stunting didefinisikan sebagai keadaan dimana status gizi pada anak menurut TB/U dengan hasil nilai Z Score = <-2 SD, hal ini menunjukkan keadaan tubuh yang pendek atau sangat pendek hasil dari gagal pertumbuhan. Stunting pada anak juga menjadi salah satu faktor risiko terjadinya kematian, masalah perkembangan motorik yang rendah, kemampuan berbahasa yang rendah, dan adanya ketidakseimbangan fungsional (Anwar, Khomsan, dan Mauludyani, 2014).

Wasting merupakan kurangnya berat badan menurut panjang/tinggi badan anak (BB/TB). Panjang badan digunakan untuk anak berumur kurang dari 24 bulan dan tinggi badan digunakan untuk anak berumur 24 bulan ke atas. Balita kurus (wasting) disebabkan karena kekurangan makan atau terkena penyakit infeksi yang terjadi dalam waktu yang singkat. Karakteristik masalah gizi yang ditunjukkan oleh balita kurus adalah masalah gizi akut.

Data prevalensi balita stunting yang dikumpulkan World Health Organization (WHO), Indonesia termasuk ke dalam negara ketiga dengan prevalensi tertinggi di regional Asia Tenggara/South-East Asia Regional (SEAR). Rata-rata prevalensi balita stunting di Indonesia tahun 2005-2017 adalah 36,4%. Berdasarkan data riskesdas dari tahun 2007 hingga tahun 2018 terdapat penurunan balita sangat pendek 12 (stunting berat) sebesar 6,4 %. Namun prevalensi balita pendek atau stunting mengalami peningkatan sebesar 1,3%. Prevalensi balita sangat pendek dan pendek usia 0-59 bulan di Indonesia tahun 2017 adalah 9,8% dan 19,8%. Kondisi ini meningkat dari tahun sebelumnya yaitu prevalensi balita sangat pendek sebesar 8,5% dan balita pendek sebesar 19%.

Komitmen pemerintah dalam upaya percepatan perbaikan gizi telah dinyatakan melalui Perpres Nomor 42 Tahun 2013, tanggal 23 Mei 2013, tentang Gerakan Nasional (Gernas) Percepatan Perbaikan Gizi yang merupakan upaya bersama antara pemerintah dan masyarakat melalui penggalangan partisipasi dan kepedulian

pemangku kepentingan secara terencana dan terkoordinasi untuk percepatan perbaikan gizi masyarakat. Untuk itu Rumah sakit membuat Pedoman Kerja dalam upaya menurunkan prevalensi stunting dan wasting terutama di rumahsakit Prima Husada.

1.2 Tujuan

a. Tujuan Umum

Meningkatkan Pelayanan Kesehatan dan Gizi yang bermutu dalam upaya penurunan prevalensi Stunting pada bayi dan balita di Indonesia.

b. Tujuan Khusus

1. Terlaksananya manajemen pelayanan kesehatan dan gizi terkait kasus stunting yang ada di RS Prima Husada
2. Terlaksananya system rujukan pelayanan kesehatan dan gizi stunting pada bayi dan anak.
3. Pembinaan dan pengawasan pelayanan kesehatan dan gizi di RS.

1.3 Sasaran

Sasaran dari kegiatan Program penurunan prevali stunting dan wasting adalah seluruh staf medis dan non medis, pasien, serta keluarga pasien RS Prima Husada Malang.

BAB II PENGORGANISASIAN

2.1 SDM

2.1.1 Ketenagaan

Ketua	: dr. Fiona Paramitha, Sp. A
Sekretaris	: Chandrawati Mustikasari, S. Tr. Gz
Staf Keperawatan	: Sistha Gea Aprillia, Amd. Kep : Mike Maulina Sri Hartati S. Kep, Ners : Nuraini Radika Rifqi, S. Kep., Ns
Staf Instalasi farmasi	: Pipin Purwa Ningrum, S. Farm., Apt
Staf Instalasi Gizi	: Nafisah Ulfa Hasanah, S. Gz
Tim Tumbuh Kembang	: Tuti Dwi Jayati, AMd. Keb
Tim Humas Rumah Sakit	: Mayputri Nabilla

2.1.2 Orientasi

Orientasi dilakukan kepada anggota baru dengan diberikan penjelasan mengenai jabatan, uraian tugas, tanggung jawab dan wewenang.

2.1.3 Pendidikan dan Pelatihan

No	SDM	Jumlah	Keterangan
1	Ketua Tim dan Stunting Wasting	1	Dokter spesialis anak yang sudah berkompeten di bidang tumbuh kembang anak
2	Sekretaris Tim dan Stunting Wasting	1	Sudah mengikuti pendidikan dan pelatihan mengenai stunting dan wasting
3	Anggota Tim dan Stunting wasting	6	Sudah mengikuti pendidikan dan pelatihan mengenai stunting dan wasting

2.1.4 Kriteria

a. Ketua tim stunting

Persyaratan Jabatan minimal:

- 1) Sarjana Kesehatan diutamakan dokter Spesialis Anak (dr.Sp.A)
- 2) Berpengalaman di bidang stunting minimal selama 3 tahun
- 3) Mempunyai kemampuan dan ketrampilan komunikasi Informasi dan Edukasi.
- 4) Mampu, mau dan bertanggungjawab

b. Sekretaris tim stunting:

- 1) Mempunyai kemampuan dan ketrampilan komunikasi Informasi dan Edukasi.
- 2) Mampu, mau dan bertanggungjawab

c. Anggota tim stunting:

- 1) Mempunyai kemampuan dan ketrampilan komunikasi Informasi dan Edukasi.
- 2) Mampu, mau dan bertanggungjawab

2.1.5 Tugas dan Tanggung Jawab

a. Ketua Tim Stunting

1). Uraian Tugas

- a) Membuat rencana program kerja Tim Stunting
- b) Melaksanakan semua program Tim Stunting
- c) Memimpin dan mengkoordinir semua pelaksanaan operasional tim Stunting secara efektif, efisien dan bermutu
- d) Menyelenggarakan komunikasi yang efektif dan mewakili pendapat, kebijakan, laporan, kebutuhan dan keluhan Tim Stunting termasuk keluhan eksternal Tim
- e) Menyelenggarakan dan bertanggungjawab atas semua risalah rapat yang diselenggarakan Tim Stunting
- f) Menghadiri pertemuan yang diadakan oleh Direktur Rumah Sakit Prima Husada dan kepanitiaanlainnya dan undangan dinas terkait
- g) Mengkoordinir semua laporan kegiatan tim stunting.
- h) Memonitor dan mengevaluasi semua pelaksanaan program kerja Tim Stunting

2). Tanggungjawab

- a) Bertanggungjawab pada Direktur RS Prima Husada
- b) Bertanggungjawab terhadap perencanaan, pelaksanaan dan monev semua program kerja tim stunting dan wasting RS secara paripurna.
- c) Bertanggungjawab terhadap laporan, penyajian data dan semua informasi yang dikeluarkan Tim dari hasil pelaksanaan program pelayanan Stunting dan wasting kepada Direktur RS PrimaHusada dan ataupun dari dinas terkait.

b. Sekretaris Tim Stunting

1). Uraian Tugas

- a) Membuat dan mendokumentasikan surat keluar tim Stunting
- b) Mengarsip surat masuk dan dokumen-dokumen tim Stunting
- c) Membantu mengkoordinir semua usulan perencanaan pembuatan program kerja tim Stunting
- d) Membantu pembuatan pedoman kerja tim Stunting
- e) Membantu pembuatan spo terkait kegiatan program Layanan Kesehatan dan Gizi Cegah Stunting Sejak Dini

-
- f) Melakukan semua kegiatan administrasi tim Stunting
 - g) Menyebarluaskan informasi tentang : Regulasi, kebijakan, referensi, kepada semua anggota tim Stunting
 - h) Menyiapkan undangan, materi, daftar absensi, konsumsi, ATK, dan ruangan untuk rapat, pertemuan ataupun Diklat serta acara terkait program kerja Tim
 - i) Membantu membuat TOR baik untuk usulan kegiatan, diklat, alat dll.
 - j) Membantu pembuatan laporan triwulan program kerja tim Stunting.
 - k) Meminta atau menagih laporan kepada unit kerja pelaksana program terkait Stunting
 - l) Membantu menganalisis data hasil kegiatan program
 - m) mendokumentasikan hasil dari pelayanan Kesehatan dan Gizi Stunting
 - n) Mengorganisir kebutuhan logistik tim Stunting
 - o) Membantu koordinasi dalam kegiatan internal dan eksternal tim Stunting

2). Tanggungjawab

- a) Bertanggungjawab pada ketua tim Stunting
- b) Bertanggungjawab terhadap semua tugas-tugas administratif tim Stunting
- c) Bertanggungjawab terhadap penyimpanan ataupun pengarsipan semua kelengkapan berkas: regulasi, referensi, persuratan, materi-materi KIE, dan yang terkait dengan program pelayanan Kesehatan dan Gizi Cegah Stunting di rumah sakit

c. Anggota Tim Stunting

1). Uraian Tugas

- a) Mengusulkan semua kebutuhan materi pembuatan program kerja Tim
- b) Mengusulkan rencana kegiatan yang akan dimasukkan dalam program kerja Tim
- c) Melaksanakan semua Program pelayanan kesehatan dan gizi cegah stunting di rumah sakit
- d) Melakukan pengumpulan data dan menjadikan data tsb sebagai informasi untuk pelayanan kesehatan dan gizi cegah stunting di rumahsakit dari unit pelaksana/unit kerja terkait
- e) Membuat Materi edukasi bentuk apapun untuk kebutuhan KIE pasien dan keluarga untuk peningkatan kualitas gizi dalam upaya preventif, promotif, kuratif.
- f) Melakukan monitoring dan investigasi terhadap pelayanan kesehatan dan gizi cegah stunting di rumahsakit dari unit kerja terkait
- g) Melakukan pemantauan ke FKTP dan Komunitas terkait pelayanan kesehatan dan gizi stunting

-
- h) Mengusulkan tindak lanjut dari hasil analisis pelayanan kesehatan dan gizi cegah stunting
 - i) Melaporkan hasil investigasi dan analisis kepada Ketua Tim Stunting
 - j) Melaksanakan peningkatan dan pengembangan SDM baik untuk tim maupun petugas terkait program stunting baik internal RS maupun eksternal RS

2). Tanggungjawab

- a) Bertanggungjawab pada ketua tim Stunting
- b) Bertanggungjawab pada Direktur RS Prima Husada
- c) Bertanggungjawab terhadap penyusunan laporan pelayanan kesehatan dan gizi cegah stunting
- d) Bertanggungjawab melaporkan hasil pelaksanaan pelayanan kesehatan dan gizi cegah stunting ke Ketua Tim Stunting
- e) Bertanggungjawab terhadap pengolahan data dan informasi yang berhubungan dengan Investigasi pelayanan kesehatan dan gizi cegah stunting
- f) Bertanggungjawab dalam pemberian informasi yang berhubungan dengan kegiatan pelayanan kesehatan dan gizi cegah stunting

2.1.6 Evaluasi kinerja staf

Evaluasi kinerja staf dilakukan tiap trimester untuk menilai produktivitas kerja tim

BAB III RUANG LINGKUP

3.1 Terapi Gizi Terintegrasi

Ruang lingkup kegiatan pelayanan gizi di rumah sakit dibagi atas empat kegiatan pokok yaitu asuhan gizi pasien rawat jalan, asuhan gizi pasien rawat inap, penyelenggaraan makanan, penelitian dan pengembangan gizi (Depkes, 2003). Pelayanan Gizi Rumah Sakit (PGRS) merupakan bagian integral dari Pelayanan Kesehatan Paripurna Rumah Sakit dengan beberapa kegiatan antara lain pelayanan gizi rawat inap dan rawat jalan. Pemberian asuhan gizi terintegrasi pada pasien stunting dan wasting dimulai dari deteksi dini pasien stunting dan wasting, rencana pemberian terapi gizi, monitoring dan terapi gizi.

3.1.1 Deteksi Dini

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Kondisi gagal tumbuh pada anak balita disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu lama serta terjadinya infeksi berulang, dan kedua faktor penyebab ini dipengaruhi oleh pola asuh yang tidak memadai terutama dalam 1.000 HPK. Anak tergolong stunting apabila panjang atau tinggi badan menurut umurnya lebih rendah dari standar nasional yang berlaku. Standar dimaksud terdapat pada buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dan beberapa dokumen lainnya. Penurunan stunting penting dilakukan sedini mungkin untuk menghindari dampak jangka panjang yang merugikan seperti terhambatnya tumbuh kembang anak. Deteksi awal pasien stunting dan wasting diawali menggunakan alat skrining strong kids. Jika skor 1 atau lebih maka dinyatakan beresiko terkena malnutrisi.

Setelah dilakukan skrining terhadap pasien terduga stunting, jika hasil menunjukkan nilai sama atau lebih dari satu (≥ 1) maka langkah selanjutnya adalah menentukan rencana terapi nutrisi dengan melibatkan tim yang terdiri dari dokter spesialis anak, ahli gizi, perawat, dan farmasi.

Tabel 1. Tabel Skrining Strong Kids

No	Pertanyaan	Jawaban (skor)	
1	Apakah pasien tampak kurus?	Tidak (0)	Ya (1)
2	Apakah terdapat penurunan berat badan selama 1 bulan terakhir? (berdasarkan penilaian objektif data BB/penilaian subjektif dari orang tua atau bayi <1 tahun tidak ada kenaikan BB dalam 3 bulan terakhir)	Tidak (0)	Ya (1)

3	Apakah ada salah satu dari kondisi berikut ? • Diare ≥ 5 kali/hari • Muntah $>3x$/hari dalam seminggu terakhir • Diare ≥ 5 kali/hari dan atau muntah $>3x$/hari dalam seminggu terakhir • Asupan makan berkurang selama 1 minggu terakhir	Tidak (0)	Ya (1)
4	Apakah terdapat penyakit atau keadaan yang mengakibatkan pasien beresiko mengalami malnutrisi	Tidak (0)	Ya (2)
SKOR			
Tindak lanjut (lihat tabel interpretasi skor)			

Tabel 2. Interpretasi Skor Screening

Skor	Resiko	Intervensi
4-5	tinggi	Pasien mendapat asuhan nutrisi pediatrik terintegrasi yang dilakukan oleh DPJP nutrisi (formulir terintegrasi
1-3	sedang	Monitoring pasien selanjutnya akan ditentukan oleh dpjp nutrisi, apakah cukup dilakukan dietitien anak atau disarankan rawat bersama
0	rendah	Dilakukan oleh dpjp umum selanjutnya dilakukan oleh dietitien anak

Langkah lanjut yang dilakukan untuk menentukan anak stunted adalah anak stunting yaitu dengan melakukan pengukuran antropometri. Standar antropometri anak didasarkan pada parameter berat badan dan panjang badan atau tinggi badan yang terdiri dari 4 (empat) indeks, meliputi:

- Berat bada menurut umur (BB/U)
- Panjang / Tinggi Badan Menurut Umur (PB/U atau TB/U)
- Berat badan menurut panjang badan atau Tinggi Badan (BB/PB) atau (BB/TB)
- Indeks Masa Tubuh menurut umur (IMT/U)

Standar Antropometri Anak di Indonesia mengacu pada WHO Child Growth Standards untuk anak usia 0-5 tahun dan The WHO Reference 2007 untuk anak 5 (lima) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun. Standar tersebut memperlihatkan bagaimana pertumbuhan anak dapat dicapai apabila memenuhi syarat-syarat tertentu. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak dari negara manapun akan tumbuh sama bila gizi, kesehatan dan pola asuh yang benar terpenuhi.

Tabel 2. Tabel Interpretasi Standar Antropometri Penilaian Status Gizi Anak

Indeks	Kategori Status Gizi	Ambang Batas (Z-Score)
Berat Badan menurut Umur (BB/U) anak usia 0 - 60 bulan	Berat badan sangat kurang (<i>severely underweight</i>)	<-3 SD
	Berat badan kurang (<i>underweight</i>)	- 3 SD sd <- 2 SD
	Berat badan normal	-2 SD sd +1 SD
	Risiko Berat badan lebih ¹	> +1 SD
Panjang Badan atau Tinggi Badan menurut Umur (PB/U atau TB/U) anak usia 0 - 60 bulan	Sangat pendek (<i>severely stunted</i>)	<-3 SD
	Pendek (<i>stunted</i>)	- 3 SD sd <- 2 SD
	Normal	-2 SD sd +3 SD
	Tinggi ²	> +3 SD
Berat Badan menurut Panjang Badan atau Tinggi Badan (BB/PB atau BB/TB) anak usia 0 - 60 bulan	Gizi buruk (<i>severely wasted</i>)	<-3 SD
	Gizi kurang (<i>wasted</i>)	- 3 SD sd <- 2 SD
	Gizi baik (normal)	-2 SD sd +1 SD
	Berisiko gizi lebih (<i>possible risk of overweight</i>)	> + 1 SD sd + 2 SD
	Gizi lebih (<i>overweight</i>)	> + 2 SD sd + 3 SD
	Obesitas (<i>obese</i>)	> + 3 SD

Indeks	Kategori Status Gizi	Ambang Batas (Z-Score)
Umur (IMT/U) anak usia 5 - 18 tahun	Gizi kurang (<i>thinness</i>)	- 3 SD sd <- 2 SD
	Gizi baik (normal)	-2 SD sd +1 SD
	Gizi lebih (<i>overweight</i>)	+ 1 SD sd +2 SD
	Obesitas (<i>obese</i>)	> + 2 SD

3.1.2 Rencana Intervensi Gizi

Setelah melakukan screening terhadap pasien, hal yang dilakukan selanjutnya adalah membuat rencana pemberian terapi nutrisi (tata laksana terapi nutrisi) meliputi Penilaian/ Assesment terdiri dari diagnosa klinis dan antropometri, perhitungankebutuhan kalori, penentuan rute pemberian makanan, penentuan jenis diet, dan monitoring evaluasi.

a. Penilaian (Assesment)

1. Diagnosa Klinis

Penilaian riwayat penyakit, pemeriksaan fisik, hasil laboratorium, hasil radiologi, dan kebiasaan makan

2. Antropometri

Mengukur berat badan, panjang bad untuk memberikan penilaian menggunakan kurva WHO 2007 untukpenilaian status gizi.

b. Perhitungan Kebutuhan Kalori

Perhitungan kalori pada anak dengan kondisi stunting dan wasting dengan kondisi tidak kritis menggunakan rumus RDA (*Reference Dietary Intake*) sebagai berikut.

Umur (tahun)	RDA (kkal/kg)
0-6 bulan	120
6-12 bulan	110
1-3	100
4-6	94-60

Kebutuhan nutrisi tertentu secara khusus dihitung pada kondisi klinis tertentu berdasarkan antropometr status gizi. Pada anak gizi buruk menggunakan perhitungan menurut WHO yaitu $(80\text{kkal} \times \text{BB aktual fase stabilisasi pada hari 1-2})$ sesuai RDA HA yaitu pemberian kalori awal 50% pada hari 1-2 kemudian dinaikkan bertahap sampai 70-75% dari target pada hari ketiga dan seterusnya sampai 100% dari target untuk menghindari sindrom feeding.

c. Rute Pemberian

Rute pemberian makan pada pasien stunting dan wasting dapat melalui oral, enteral, dan parenteral

d. Jenis Diet

Jenis diet pada pasien stunting dan wasting ditentukan sesuai dengan kondisi pasien.

e. Monitoring dan evaluasi

Monitoring dan evaluasi pemberian intervensi pada pasien stunting dan wasting yaitu berdasarkan

- 1) Kemampuan menerima diet yang diberikan
- 2) Toleransi (tanda-tanda reaksi simpang)

- 3) Keberhasilan dan efektifitas
- 4) Evaluasi kenaikan berat badan
Pasien dengan gizi buruk (50g/minggu) dan gizi kurang (6-8 gram/hari)

3.2 Rujukan

Pengiriman pasien rujukan harus dilaksanakan sedini mungkin untuk perawatan lebih lanjut termasuk pendampingan program gizi ke sarana pelayanan yang lebih lengkap. Unit pelayanan kesehatan yang menerima rujukan harus merujuk kembali pasien ke sarana kesehatan yang mengirim, untuk mendapatkan pengawasan perawatan termasuk rehabilitasi selanjutnya. Pasien yang akan dirujuk harus sudah diperiksa dan layak untuk dirujuk. Adapun kriteria pasien yang dirujuk adalah bila memenuhi salah satu dari :

1. Hasil pemeriksaan fisik sudah dapat dipastikan tidak mampudiatasi.
2. Hasil pemeriksaan fisik dengan pemeriksaan penunjang medis ternyata tidak mampu diatasi.
3. Memerlukan pemeriksaan penunjang medis yang lebih lengkap, tetapi pemeriksaan harus disertai pasien yang bersangkutan.
4. Apabila telah diobati dan dirawat ternyata memerlukan pemeriksaan, pengobatan dan perawatan di sarana kesehatan yang lebih mampu. Dalam prosedur merujuk dan menerima rujukan pasien ada dua pihak yang terlibat yaitu pihak yang merujuk dan pihak yang menerima rujukan dengan rincian beberapa prosedur sebagai berikut :
 1. Prosedur standar merujuk pasien
 - a) Prosedur Klinis :
 - 1) Melakukan anamnesa, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang medik untuk menentukan diagnosa utama
 - 2) Memberikan tindakan pra rujukan sesuai kasus
 - 3) Memutuskan unit pelayanan tujuan rujukan.
 - 4) Untuk pasien gawat darurat harus didampingi petugas Medis
 - 5) Apabila pasien diantar dengan kendaraan Puskesmas keliling atau ambulans, agar petugas dan kendaraan tetap menunggu pasien di IGD tujuan sampai ada kepastian pasien tersebut mendapat pelayanan dan kesimpulan dirawat inap atau rawat jalan.
 - b) Prosedur Administratif:
 - 1) Dilakukan setelah pasien diberikan tindakan pra-rujukan.
 - 2) Membuat catatan rekam medis pasien.
 - 3) Memberikan *Informed Consent* (persetujuan/penolakan rujukan)
 - 4) Membuat surat rujukan pasien rangkap, dimana lembar pertama dikirim ke tempat rujukan bersama pasien yang bersangkutan dan lembar kedua disimpan sebagai arsip.
 - 5) Mencatat identitas pasien pada buku register rujukan pasien.

-
- 6) Menyiapkan sarana transportasi dan sedapat mungkin menjalin komunikasi dengan tempat tujuan rujukan.
 - 7) Pengiriman pasien ini sebaiknya dilaksanakan setelah diselesaikan administrasi yang bersangkutan.

2. Prosedur standar menerima rujukan pasien

a. Prosedur Klinis:

- 1) Segera menerima dan melakukan stabilisasi pasien rujukan
- 2) Setelah stabil, meneruskan pasien ke ruang perawatan elektif untuk perawatan selanjutnya atau meneruskan ke sarana kesehatan yang lebih mampu untuk dirujuk lanjut.
- 3) Melakukan monitoring dan evaluasi kemajuan klinis pasien.

b. Prosedur Administratif:

- 1) Menerima, meneliti dan menandatangani surat rujukan pasien yang telah diterima untuk ditempelkan di kartu status pasien.
- 2) Apabila pasien tersebut dapat diterima kemudian membuat tanda terima pasien sesuai aturan masing-masing sarana.
- 3) Mengisi hasil pemeriksaan dan pengobatan serta perawatan pada kartu catatan medis dan diteruskan ke tempat perawatan selanjutnya sesuai kondisi pasien.
- 4) Membuat informed consent (persetujuan tindakan, persetujuan rawat inap atau pulang paksa).
- 5) Segera memberikan informasi tentang keputusan tindakan perawatan yang akan dilakukan kepada petugas/keluarga pasien yang mengantar.
- 6) Apabila tidak sanggup menangani (sesuai perlengkapan Puskesmas yang bersangkutan), maka harus merujuk ke RS yang lebih mampu
- 7) Mencatat identitas pasien di buku register yang ditentukan.

3. Prosedur standar memberi rujukan balik pasien

a. Prosedur Klinis:

- 1) Rumah Sakit menerima rujukan pasien akan mengembalikan pasien ke Puskesmas pengirim setelah dilakukan proses pemeriksaan medis, didampingi, dirawat dan di-*follow up* oleh Rumah Sakit dan penyembuhan selanjutnya dilakukandi Puskesmas
- 2) Melakukan pemeriksaan fisik dan mendiagnosa bahwa kondisi pasien sudah memungkinkan untuk keluar dari perawatan Rumah Sakit tersebut dalam keadaan:
 - a) Sehat atau Sembuh.
 - b) Sudah ada kemajuan klinis dan boleh rawat jalan.
 - c) Belum ada kemajuan klinis dan harus dirujuk ke tempat lain.
 - d) Pasien sudah meninggal.
- 3) Rumah Sakit yang menerima rujukan pasien harus memberikan laporan/informasi medis/balasan rujukan kepada Puskesmas mengenai kondisi klinis terakhir pasien

b. Prosedur Administratif:

-
- 1) Rumah Sakit yang merawat pasien berkewajiban memberi surat balasan rujukan untuk setiap pasien rujukan yang pernah diterimanya kepada Puskesmas yang
 - 2) Surat balasan rujukan boleh dititip melalui keluarga pasien yang bersangkutan dan untuk memastikan informasi balik tersebut diterima petugas kesehatan yang dituju, dianjurkan berkabar lagi melalui sarana komunikasi yang memungkinkan seperti via telepon.

4. Prosedur standar menerima rujukan balik pasien.

a. Prosedur Klinis:

- 1) Melakukan kunjungan rumah pasien dan melakukan pemeriksaan fisik.
- 2) Memperhatikan anjuran tindakan yang disampaikan oleh Rumah Sakit yang terakhir merawat pasien tersebut
- 3) Melakukan tindak lanjut atau perawatan kesehatan masyarakat dan memantau (*follow up*) kondisi klinis pasien sampai sembuh.

b. Prosedur Administratif:

Meneliti isi surat balasan rujukan dan mencatat informasi tersebut di buku register pasien rujukan, kemudian menyimpannya pada rekam medis pasien yang bersangkutan dan memberi tanda tanggal/jam telah ditindaklanjuti

2.2 STUNTING

Stunting (balita pendek) di Indonesia merupakan masalah gizi yang masih menjadi prioritas, hal ini karena permasalahan gizi berdampak pada kualitas sumber daya manusia (SDM). Prevalensi stunting di Indonesia berdasarkan Riskesdas tahun 2018 mengalami penurunan sekitar 7,2 % dari 37, 2 % prevalensi stunting secara Nasional tahun 2017 namun angka ini masih dibawah target yang ditetapkan oleh WHO yaitu dibawah 20 %.

Stunting adalah salah satu keadaan malnutrisi yang berhubungan dengan ketidakcukupan zat gizi masa lalu sehingga termasuk dalam masalah gizi yang bersifat kronis. Stunting diukur sebagai status gizi dengan memperhatikan tinggi atau panjang badan, umur, dan jenis kelamin balita. Stunting merupakan gangguan pertumbuhan fisik yang ditandai dengan penurunan kecepatan pertumbuhan dan merupakan dampak dari ketidakseimbangan gizi. Menurut World Health Organization (WHO) Child Growth Standart, stunting didasarkan pada indeks panjang badan dibanding umur (PB/U) atau tinggi badan dibanding umur (TB/U) dengan batas (z-score) kurang dari -2 SD.

Stunting terjadi mulai janin masih dalam kandungan dan baru nampak saat anak berusia dua tahun. Kekurangan gizi pada usia dini meningkatkan angka kematian bayi dan anak, menyebabkan penderitanya mudah sakit dan memiliki postur tubuh tak maksimal saat dewasa. Kemampuan kognitif para penderita juga berkurang, sehingga mengakibatkan kerugian ekonomi jangka panjang bagi Indonesia. Kejadian stunting merupakan dampak dari asupan gizi yang kurang, baik dari segi kualitas maupun kuantitas, tingginya kesakitan, atau merupakan kombinasi dari keduanya. Kondisi tersebut sering dijumpai di negara dengan kondisi ekonomi kurang.

Menurut Dalimunthe (2015) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa banyak faktor yang menyebabkan stunting. Faktor tersebut berkaitan antara satu dan yang lain. Asupan makanan yang tidak seimbang merupakan penyebab utama terjadinya stunting yaitu berhubungan dengan zat-zat penting yang terkandung dalam makanan yaitu karbohidrat, protein, lemak, mineral, vitamin, dan air. Faktor risiko lainnya yaitu riwayat penyakit sebelumnya dan berat badan lahir rendah (BBLR). Status gizi balita buruk adalah hasil dari saling berkaitannya banyak faktor determinan, antara lain kelayakan tempat tinggal, akses pangan, dan pelayanan pada kesehatan. Hasil penelitian Semba (2008), menunjukkan tingkat pendidikan orangtua, BBLR, usia balita, gender dan tempat tinggal merupakan faktor penyebab stunting. Balita stunting juga memiliki hubungan dengan usia dan pendidikan ibu, serta tingkat pengeluaran dalam keluarga. Faktor tidak langsung terhadap kejadian stunting seperti status sos-ekonomi keluarga diantaranya penghasilan keluarga, pendidikan orang tua, pengetahuan tentang gizi ibu, dan jumlah keluarga.

2.3 RUJUKAN

Rujukan adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab atas kasus penyakit atau masalah kesehatan yang diselenggarakan secara timbal balik, baik secara vertikal dalam arti satu strata sarana pelayanan kesehatan ke strata sarana pelayanan kesehatan lainnya, maupun secara horisontal dalam arti antar sarana pelayanan kesehatan yang sama.

Jenis rujukan Sistem Kesehatan Nasional membedakannya menjadi dua macam yakni :

- 1) Rujukan Kesehatan Rujukan ini terutama dikaitkan dengan upaya pencegahan penyakit dan peningkatan derajat kesehatan. Dengan demikian rujukan kesehatan

pada dasarnya berlaku untuk pelayanan kesehatan masyarakat (public health service). Rujukan kesehatan dibedakan atas tiga macam yakni rujukan teknologi, sarana, dan operasional. Rujukan kesehatan yaitu hubungan dalam pengiriman, pemeriksaan bahan atau specimen ke fasilitas yang lebih mampu dan lengkap. Ini adalah rujukan yang menyangkut masalah kesehatan yang sifatnya pencegahan penyakit (preventif) dan peningkatan kesehatan (promotif). Rujukan ini mencakup rujukan teknologi, sarana dan operasional.

- 2) Rujukan Medik Rujukan ini terutama dikaitkan dengan upaya penyembuhan penyakit serta pemulihan kesehatan. Dengan demikian rujukan medik pada dasarnya berlaku untuk pelayanan kedokteran (medical service). Sama halnya dengan rujukan kesehatan, rujukan medik ini dibedakan atas tiga macam yakni rujukan penderita, pengetahuan dan bahan pemeriksaan. Menurut Syafrudin (2009), rujukan medik yaitu pelimpahan tanggung jawab secara timbal balik atas satu kasus yang timbul baik secara vertikal maupun horizontal kepada yang lebih berwenang dan mampu menangani secara rasional. Jenis rujukan medik antara lain: 1) Transfer of patient Konsultasi penderita untuk keperluan diagnosis, pengobatan, tindakan operatif dan lain-lain. 2) Transfer of specimen Pengiriman bahan (spesimen) untuk pemeriksaan laboratorium yang lebih lengkap. 3) Transfer of knowledge / personal. Pengiriman tenaga yang lebih kompeten atau ahli untuk meningkatkan mutu layanan setempat.

BAB IV
PROGRAM KERJA

No	KEGIATAN POKOK	RINCIAN KEGIATAN
1	Peningkatan pemahaman dan kesadaran seluruh staf, pasien dan keluarga tentang masalah stunting dan wasting	- Melakukan pelatihan internal - Menyusun jadwal - Membuat Proposal kegiatan - Membuat undangan kegiatan - Membuat Daftar hadir - Membuat materi pelatihan - Membuat soal pre dan Post test - Membuat Notulen pelatihan. - Membuat sertifikat pelatihan - Memberikan edukasi terkait gizi seimbang untuk ibu hamil - Memberikan edukasi terkait gizi seimbang pada bayi dan balita yang mengalami stunting dan wasting
2.	Intervensi spesifik di rumah sakit	- Program 1000 HPK - Suplementasi Tablet Besi Folat pada ibu hamil - Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pada ibu hamil - Promosi Konseling IMD dan ASI eksklusif - Pemberian Makanan Bayi dan Anak (PMBA) - Pemantauan Pertumbuhan Bayi dan Balita - Pemberian Imunisasi - Pemberian Makanan Tambahan Balita Gizi Kurang - Pemberian Vitamin A (mengikuti program pemerintah) - Pemberian taburia pada baduta (0-23 bulan) - Pemberian obat cacing pada ibu hamil (mengikuti program pemerintah)
3.	Penerapan rumah sakit sayang ibu bayi	- Menyelenggarakan pelayanan antenatal termasuk konseling kesehatan maternal dan neonatal, serta konseling pemberian ASI - Menyelenggarakan persalinan bersih dan aman serta penanganan pada bayi baru lahir dengan inisiasi menyusui dini dan kontak kulit ibu-bayi - Menyelenggarakan PONEK selama 24 jam - Menyelenggarakan pelayanan imunisasi bayi dan tumbuh kembang - Menyelenggarakan pelayanan kesehatan keluarga berencana (KB)
4.	Rumah sakit sebagai pusat rujukan kasus	Rumah Sakit sebagai pusat rujukan kasus stunting untuk memastikan kasus, penyebab

	stunting dan wasting	dan tatalaksana lanjut oleh Dokter Spesialis Anak 2. Rumah Sakit sebagai pusat rujukan balita gizi buruk dengan komplikasi medis 3. Rumah sakit dapat melakukan pendampingan klinis dan manajemen serta penguatan jejaring rujukan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) di wilayahnya dalam tatalaksana stunting dan gizi buruk.
5.	Rumah sakit sebagai pedamping klinis dan manajemen serta jejaring rujukan	1. Membuat suatu perjanjian kerjasama dengan jejaring rujukan rumah sakit terkait hal-hal yang disepakati dalam proses rujukan pasien 2. Melaksanakan pembinaan terhadap jejaring rujukan rumah sakit. Pembinaan berupa refreshing kembali tentang kriteria dan indikasi pasien yang dirujuk, stabilisasi pasien sebelum dirujuk, kelengkapan rujukan serta penyampaian prosedur rujukan di RSPHM kepada jejaring rujukan RS. 3. Melaksanakan evaluasi pembinaan terhadap jejaring rujukan 3 bulan setelah dilakukan pembinaan.
6.	Program pemantauan dan evaluasi	1. Melakukan monitoring evaluasi terkait edukasi yang sudah diberikan dan melakukan pengukuran antropometri secara berkala untuk mengetahui efektifitas terapi yang diberikan 2. Membuat laporan dan evaluasi kegiatan

BAB V
TATA LAKSANA

No	RINCIAN KEGIATAN	TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET PENCAPAIAN	ALAT PENGUKUR
1	Peningkatan pemahaman dan kesadaran seluruh staf, pasien dan keluarga tentang masalah stunting dan wasting	Dilakukan di ruang rawat inap dan hall RS Prima Husada	Ibu hamil, bayi, balita dan staff RS Prima Husada	- Pasien dan keluarga pasien memahami pengertian stunting, tanda dan gejala stunting dan wasting - Staff RS dapat melakukan identifikasi stunting dengan tepat	Pre & Post Test
2	Intervensi spesifik di rumah sakit	Dilakukan di ruang rawat inap RS Prima Husada	Ibu hamil, bayi dan balita di RS Prima Husada	- Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan - Meningkatkan asupan gizi seimbang bagi Ibu hamil, bayi dan balita - Meningkatkan status gizi menjadi lebih baik	- Pre & Post Test - Status Gizi Pasien
3	Penerapan rumah sakit sayang ibu bayi	Dilakukan di Rumah sakit Prima Husada	Ibu hamil, Ibu menyusui, bayi dan balita	Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan	- Pre & Post Test - Form penilaian dari pasien dan keluarga
4	Rumah sakit sebagai pusat rujukan kasus stunting dan wasting	Dilakukan RS Prima Husada	Bayi dan Balita	- Rujukan yang sesuai dengan kebijakan - Bayi atau balita yang dirujuk dapat kembali pulang ke rumah dalam keadaan sehat	Status/keadaan saat pasien pulang
5	Rumah sakit sebagai pedamping klinis dan manajemen	Dilakukan di RS Prima Husada	Bayi dan Balita Stunting	Rumah sakit dapat melakukan pendampingan klinis dan manajemen serta	Surat MOU

	serta jejaring rujukan			penguatan jejaring rujukan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) di wilayahnya	
6	Program pemantauan dan evaluasi	Dilakukan di RS Prima Husada	Ibu hamil, bayi, balita dan staff RS Prima Husada	• Meningkatkan kemampuan tenaga kesehatan terkait identifikasi kasus stunting • Pemahaman Ibu Hamil terkait asupan gizi yang seimbang • Pemahaman ibu menyusui terkait pemberian asi eksklusif	• Laporan hasil monitoring dan evaluasi program

3.3.1 Pelayanan intervensi spesifik a. Program 1000 HPK

Tabel 18. Tabel Program 1000 HPK

KELOMPOK SASARAN	INTERVENSI PRIORITAS	INTERVENSI PENDUKUNG	INTERVENSI PRIORITAS SESUAI KONDISI TERTENTU
Ibu Hamil	• Pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dari kelompok miskin/ Kurang Energi Kronik(KEK) • Suplementasi tablet tambah darah	• Suplementasi kalsium • Pemeriksaan kehamilan	• Perlindungan dari malaria • Pencegahan HIV
Ibu menyusui dan anak 0-23 bulan	• Promosi dan konseling menyusui • Promosi dan konseling pemberian makan bayi dan anak (PMBA) • Tata laksana gizi	• Suplementasi kapsul vitamin A • Suplementasi taburia • Imunisasi • Suplementasi zinc untuk pengobatan diare • Manajemen terpadu balita sakit	• Pencegahan kecacingan

	buruk • Pemberian makanan tambahan pemulihan bagianak kurus • Pemantauan dan promosi • Pertumbuhan	(MTBS)	
--	--	--------	--

b. Suplementasi Tablet Besi Folat pada ibu hamil

Pemberian tablet besi folat pada ibu hamil diberikan jika ibu belum pernah mengkonsumsi atau mendapatkan tablet besi folat. Penggunaan Tablet Besi Folat untuk lebih efektif :

- 1) Tablet besi folat diminum pada malam hari sebelum tidur untuk mengurangi rasa mual
- 2) Tablet besi folat dikonsumsi bersamaan makanan atau minuman yang mengandung vitamin C seperti buah segar, sayuran, jus buah, untuk membantu penyerapan zat besi dalam tubuh maksimal
- 3) Tidak konsumsi tablet besi folat bersama dengan teh, kopi, susu, obat sakit maag karena dapat menghambat penyerapan zat besi.

c. Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pada Ibu Hamil

Pada masa hamil ada banyak program pelayanan kesehatan yang dilakukan salah satunya adalah pencegahan kekurangan energy kronis (KEK) pada ibu hamil. KEK merupakan kondisi malnutrisi yang dimana seseorang mengalami kekurangan gizi (kalori dan protein) yang berlangsung lama atau menahun. Menurut Kemenkes, indikator KEK pada ibu hamil dapat dilihat dari LILA (lingkar lengan atas) yang kurang dari 23,5 cm. KEK secara umum disebabkan oleh pola konsumsi nutrisi yang kurang. Ibu hamil dengan KEK berisiko melahirkan bayi berat lahir rendah (BBLR) juga dapat menjadi penyebab tidak langsung kematian ibu serta berdampak pada meningkatnya prevalensi stunting di Indonesia.

Tatalaksana pemberian makanan tambahan pada ibu hamil :

- 1) Deteksi ibu hamil KEK jika LLA <23,5 cm di awal kehamilan
- 2) Deteksi KEK dilakukan di poli rawat jalan kebidanan dan kandungan dan ruang rawat inap kebidanan dan kandungan dengan melihat KMS atau pengukuran LLA
- 3) Ibu hamil diberikan media leaflet dengan materi pengertian PMT untuk ibu hamil, kebutuhan tambahan zat gizi, anjuran konsumsi, contoh menu, dan pesan penting.

d. Promosi dan Konseling IMD dan ASI Eksklusif

Untuk menekan angka kematian bayi, salah satunya adalah dengan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan dilanjutkan dengan pemberian ASI secara eksklusif sampai bayi berusia 6 bulan. Keberhasilan pemberian ASI eksklusif berawal dari terlaksananya proses IMD secara optimal. Disamping menjadi titik awal keberhasilan ASI Eksklusif, IMD diyakini memiliki banyak manfaat bagi ibu

yaitu saat sentuhan, hisapan, dan jilatan bayi pada puting ibu selama proses inisiasi menyusui dini akan merangsang keluarnya hormon oksitosin yang menyebabkan rahim berkontraksi sehingga membantu pengeluaran plasenta dan mengurangi perdarahan pada ibu.

Kontak kulit membantu proses kolonisasi kulit, dimana bakteri yang menempel pada kulit ibu dan dijilat oleh bayi, diketahui bahwa bakteri tersebut bermanfaat bagi bayi, berperan sebagai zat antibodi untuk melindungi bayi dari kuman penyakit di lingkungan luar bayi. Menurut penelitian diketahui bahwa bayi yang diberi kesempatan menyusui dini akan berhasil menyusui eksklusif delapan kali lebih besar dibandingkan bayi yang tidak diberi kesempatan menyusui dini. Ini berarti bahwa bayi selanjutnya akan lebih mungkin untuk disusui sampai usianya mencapai dua tahun bahkan lebih. Manfaat IMD baik bagi bayi maupun ibunya sangat besar.

Tatalaksana :

- 1) Promosi dan Konseling IMD dan Asi Eksklusif dilakukan oleh Bidan di Poli Rawat Kandungan dan di Rawat Inap PONEK. Tenaga kesehatan dan penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan melakukan proses IMD pada setiap ibu segera setelah proses melahirkan, memberikan informasi dan edukasi mengenai pentingnya IMD kepada ibu dan keluarganya semenjak pemeriksaan kehamilan sampai dengan mendekati proses persalinan.
- 2) Media KIE adalah leaflet IMD dan Asi Eksklusif dengan materi pengertian IMD dan Asi Eksklusif, manfaat pemberian ASI bagi ibu, dan perilaku bayi saat menyusui pertama kali.

e. Pemberian Makanan Bayi dan Anak (PMBA)

Pemberian makanan yang cukup pada periode awal kehidupan merupakan hal yang vital bagi pertumbuhan dan perkembangan bayi dan anak. Salah satu program pemerintah yang sedang dijalankan sekarang yaitu dengan adanya PMBA. Pemberian makan pada bayi dan anak atau sering disingkat dengan PMBA merupakan program pemerintah untuk menurunkan angka kematian anak dan meningkatkan kualitas hidup ibu sesuai dengan Millenium Developments Goals. Selain itu, program PMBA juga bertujuan meningkatkan status gizi dan kesehatan, tumbuh kembang dan kelangsungan hidup anak di Indonesia.

Pemberian Makanan Bayi dan Anak (PMBA) yaitu:

- 1) Melakukan Inisiasi Menyusu Dini (IMD), memberikan ASI Eksklusif, memberikan Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) mulai usia 6 bulan dan melanjutkan pemberian ASI hingga bayi berusia 2 tahun serta anak usia diatas 1 tahun mendapatkan makanan seperti keluarga,
- 2) Memelihara kesehatan bayi dan anak,
- 3) Meningkatkan interaksi antara orang tua dan anak dengan melakukan kegiatan yang disukai anak seperti bermain, mendongeng, menyanyi serta memberikan contoh-contoh tingkah laku sehari-hari yang baik dan benar kepada anak.

Tabel 19. Pemberian MP-ASI Anak Usia 6-24 Bulan yang Dianjurkan

Usia	Frekuensi (perhari)	Jumlah yang diberikan	Tekstur
Bubur kental	2 sampai 3 kali makan ditambah ASI	Mulai dengan 2 sampai 3 sendok makan. Mulai dengan pengenalan rasa dan secara perlahan tingkatkan jumlahnya	
Dari usia 6 sampai 9 bulan	2-3 kali makan ditambah ASI 1-2 kali makanan	2 sampai 3 sendok makan penuh setiap kali makan tingkatkan secara perlahan sampai $\frac{1}{2}$	Bubur kental/makanan keluarga yang
Dari usia 9 sampai 12 bulan	3-4 kali makan ditambah ASI 1-2 kali makanan Selingan	$\frac{1}{2}$ (setengah) sampai $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) mangkuk berukuran 250 ml	Makanan keluarga yang dicincang/dica cah. Makanan dengan potongan kecil yang dapat dipegang makanan yang diiris-iris
Dari usia 12-24 bulan	3 sampai 4 kali makan ditambah ASI 1 sampai 2 kali makanan	$\frac{3}{4}$ (tiga perempat) sampai 1 (satu) mangkuk ukuran 250 ml	Makanan yang diiris-iris makanan keluarga
Catatan : Jika anak kurang dari 24 bulan tidak diberi ASI	Tambahkan 1-2 kali makan ekstra 1 sampai 2 kali makanan selingan bias diberikan	Sama dengan di atas menurut kelompok usia	Sama dengan diatas menurut kelompok usia

Edukasi PMBA dilakukan oleh ahli gizi dengan media leaflet serta pemberian makanan untuk pasien stunting dan gizi kurang beserta jam distribusi makanan :

1) 07.00 : Makan pagi (nasi/nasi tim/bubur kasar/bubur halus)

- 2) 10.0 : Snack
- 3) 12.00 : Makan siang (nasi/nasi tim/bubur kasar/bubur halus)
- 4) 17.00: Makan sore (nasi/nasi tim/bubur kasar/bubur halus)

f. Pemberian Imunisasi

Imunisasi sangat penting untuk bayi. Antibodi bayi belum lengkap, sehingga perlu dilakukan vaksinasi pada bayi berupa imunitas untuk mencegah berbagai penyakit sewaktu-waktu. Jika bayi tidak diimunisasi, kemungkinan risikonya antara lain tuberkulosis, hepatitis, polio, tetanus, difteri, batuk rejan, meningitis, pneumonia, infeksi telinga, campak, flu, gondongan bahkan rubella. Melalui imunisasi, setidaknya kemungkinan penyebaran virus atau bakteri penyebab penyakit bisa diminimalisir.

Vaksin hepatitis B harus diberikan segera setelah lahir, karena vaksin hepatitis B merupakan tindakan pencegahan yang sangat efektif yang dapat memutuskan rantai penularan dari ibu ke bayi segera setelah lahir. Oleh karena itu, semua bayi harus menerima dosis pertama vaksin hepatitis B segera setelah lahir dan sebelum dipulangkan. Bayi yang lahir dari ibu dengan HBsAg yang tidak diketahui harus menerima dosis pertama vaksin hepatitis B dalam waktu 12 jam setelah lahir.

Hepatitis B 0-7 hari harus diberikan dalam waktu 12 jam setelah lahir, dilanjutkan pada umur 1 dan 6 bulan. Apabila status surface antigen hepatitis B (HBsAg) ibu positif dalam waktu 12 jam setelah lahir diberikan HBIG 0,5 ml bersamaan dengan vaksin HB-1. Apabila semula status surface antigen hepatitis B (HBsAg) ibu tidak diketahui dan ternyata dalam perjalanan selanjutnya diketahui bahwa ibu surface antigen hepatitis B (HbsAg) positif maka masih dapat diberikan HBIG 0,5 ml sebelum bayi berumur 7 hari.

1) Jadwal Pemberian:

Sebanyak 3 kali, dengan interval 1 bulan antara suntikan pertama dan kedua, kemudian 6 bulan antara suntikan kedua dan ketiga. Intra Muskular (IM, didalam otot), 0,5 ml.

2) Usia Pemberian:

Sekurang-kurangnya 12 jam setelah lahir. Dengan syarat kondisi bayi stabil, tidak ada gangguan pada paru-paru dan jantung. Dilanjutkan pada usia 1 bulan, dan usia antara 3-6 bulan. Khusus bayi yang lahir dari ibu pengidap VHB, selain imunisasi yang dilakukan kurang dari 12 jam setelah lahir, juga diberikan imunisasi tambahan dengan imuno globulin anti hepatitis B dalam waktu sebelum berusia 24 jam.

3) Lokasi Penyuntikan

Pada anak di lengan dengan cara IM. Sedangkan pada bayi di paha lewat anterolateral (antero = otot-otot dibagian depan; lateral = otot bagian luar). Penyuntikan di bokong tidak dianjurkan karena bias mengurangi efektivitas vaksin.

g. Pemberian Makanan Tambahan Balita Gizi Kurang

Pemberian Makanan Tambahan (PMT) adalah kegiatan pemberian makanan kepada balita dalam bentuk kudapan yang aman dan bermutu beserta kegiatan pendukung lainnya dengan memperhatikan aspek mutu dan keamanan pangan. Serta mengandung nilai gizi yang sesuai dengan kebutuhan sasaran. Bahan makanan dapat diberikan oleh petugas secara langsung kepada balita gizi buruk berupa bahan makanan yaitu bisa berupa biskuit regal 250 gr dan sari kacang hijau 200 ml.

Penatalaksanaan pemberian makanan tambahan bagi balita gizi kurang:

- 1) Edukasi ditujukan kepada balita gizi kurang (z-score <-2 SD dan atau

Sasaran	Dosis	Frekuensi
Bayi 6-11 bulan	Kapsul Biru (100.000 SI)	1 kali
Anak Balita 12-59 bulan	Kapsul Merah (200.000 SI)	2 kali

dengan LLA 12,5 cm)

- 2) Edukasi dilakukan di Rawat Jalan Anak dan Rawat Inap Anak
- 3) Ibu pasien diberikan media leaflet dengan materi pengertian PMT untuk balita gizi kurang, komposisi PMT, pola pemberian, dan contoh resep.
- 4) Balita gizi kurang dapat diberikan snack berupa biskuit regal 250 gram ataupun sari kacang hijau atau bubur kacang hijau 200 ml.
- 5) Kemudian tim stunting juga melakukan pemantauan apakah PMT sudah dikonsumsi oleh pasien yang mendapatkan PMT dari Puskesmas.

h. Pemberian Vitamin A

Kapsul vitamin A yang digunakan dalam kegiatan suplementasi vitamin A adalah kapsul yang mengandung vitamin A dosis tinggi. Standar kapsul vitamin A bagi bayi 6-11 bulan, Anak Balita dan Ibu Nifas mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan No 21 Tahun 2015.

Tabel 20. Sasaran Pemberian Vitamin A

Ibu Nifas (0-42 hari)	Kapsul Merah	2 kali
	(200.000 SI)	

Penatalaksana pemberian vitamin A:

1. Melakukan pemantauan pada Buku KIA anak pada tabel pemberian Vitamin A
2. Pemberian vitamin A 100.000 IU untuk bayi usia 6-11 bulan (warna biru)
3. Pemberian vitamin A 200.000 IU untuk anak balita usia 12-59 bulan (warna merah)
4. Jika ditemukan pasien belum mendapatkan vitamin A disarankan untuk mendatangi puskesmas daerah tempat tinggal.

BAB VI PENUTUP

Demikianlah Pedoman Program Gizi Terkait Stunting dan Wasting disusun yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam menjalankan tugas dengan baik dan benar sesuai ketentuan standar pelayanan.

Pedoman Program Gizi terkait Stunting dan Wasting ini disusun dengan memperhitungkan kondisi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, oleh karenanya senantiasa untuk dilengkapi sesuai kebutuhan tuntutan pelayanan.

Akhirnya semoga Pedoman Program Gizi terkait stunting dan wasting ini dapat dipergunakan oleh seluruh tenaga kesehatan dan bermanfaat bagi peningkatan mutu layanan di rumah sakit prima husada.

Ditetapkan di : Malang
Pada Tanggal : 25 Juni 2025
Direktur Rumah Sakit Prima Husada



dr. Nur Mazidah